EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	:	HOSPITAL HERMINDA MARTIN	N° EGRESO	:	77094
SERVICIO	:	NEUROLOGIA ADULTO HHM	HC	:	2009368849
FECHA	:	2024-01-09 10:53:00	CTA. CTE.	:	754554952
			CP.	:	517910

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: YOLANDA TORRES BRIONES			**RUN**	: 5.321.297-2
F.Nac	: 22-12-1943	**Edad**	: 80 AÑOS	**Género**	: Femenino
Dirección	: ARTESANOS S/N SAN GREGORIO			**Comuna**	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 68225786		
Fecha Ingreso	: 02-01-2024	**Fecha Egreso**	: 2024-01-09 10:53:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I61.9-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- HIC parietotemporal derecha con vaciamiento ventricular, ICH 3 Día 7
- Emergencia hipertensiva
- Antecedentes: Ca Mama Operado - Dislipidemia - DM tipo 2 NIR - Disfagia

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I61-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Femenina de 80 años, vive sola, mRS=0. Antecedentes HTA difícil manejo, Ca Mama operado, Dislipidemia, DMNIR, analfabeta.
Hace 1 semana con difícil manejo HTA, alzas tensionales frecuentes con consultas en Urgencias.
El día 01/01/24 al despertar confusa, con dificultad para la marcha, cefalea moderada y persistente. Hoy 02/01 con pérdida de visión a izquierda y mayor debilidad en Hemicuerpo Izquierdo con importante limitación de la marcha por lo que consulta. No presentó compromiso de conciencia, ni convulsiones.
Consulta en SU HSC el día 02/01, PA 177/81, afebril, HGT 137, TC cerebro con extenso hematoma ParietoTemporal derecho de aprox 60 mL, con vaciamiento ventricular, sin hidrocefalia ICH=3 (edad, vaciamiento, volumen). Se deriva a HCHM para evaluación. Paciente impresiona estable, cifras tensionales en rango, al examen neurológico vigil, lenguaje conservado, hemianopsia izquierda, heminegligente a izquierda, Paresia FBC izquierda leve M4, NIHSS=11. Ingresa a UTAC manejo intensivo de PA, monitorización y neuroprotección.
Paciente evoluciona estable, con buen manejo PA, sin fiebre, buen control metabólico, en lo neurológico estable con paresia m3, resto similar, NIHSS=13. TC cbo control sin variaciones, con reabsorción de hematoma sin resangrado. AngioTC sin lesiones vasculares evidentes. En día 4 de HIC lobar de probable etiología hipertensiva, requirió manitol 24 horas, sin complicaciones, en condiciones de retorno a su centro de origen para continuar manejo médico, rehabilitación y preparación de alta, requiere sala común. Control y seguimiento por Neurología en H San Carlos.
En HSC se mantiene en buenas condiciones, cooperadora con rehabilitación y buen perfil de presiones arteriales. Logra deamubulación con asistencia de carro de marcha.
Se realizó el 08/01/24 control de TC de encéfalo sin contraste en que se evidencia estabilidad de hematoma, sin signos de complicación.
Se conversa caso con familiar y se decide en conjunto alta hospitalaria para seguimiento ambulatorio.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido segun tolerancia. Pasar a sillón en forma diaria.

2. Regimen papilla hiposodico.
3. Losartan 50 mg cada 12 horas, vía oral.
4. Hidroclorotiazida 50 mg, 1/2 comp al día, vía oral.
5. Amlodipino 10 mg, 1 comp al día, vía oral.
6. Kinesioterapia motora
7. Rehabilitación kinésica
8. Control en CAE neurología de HSC
9. Control en servicio de urgencias en caso de necesidad. Se explican situaciones de reconsulta.

EXÁMENES Y RESULTADOS

- 08/01/24 Creat 0.7, MDRD 80, Uremia 37, BUN 17, ELP 137/4.2/107, Hb 12.0, Hto 36.7, Leuco 8600, plaq 329.000, VHS 13 PCR 5.8. Tropo 14.5, TSH 1.079, T4L 1.26, VitB12 248
- 08/01/24 TC de encéfalo sin contraste: estabilidad de hematoma con reabsorción parcial.
- 04/01/24 Control de TC de encpefalo sin contraste, con estabilidad, sin signos de resangrado y sin progresión de hidrocefalia.
- 02/01/24 ANGIOTAC cerebro y cuello: sin malformación vascular subyacente
- 02/01/24: TC de encéfao sin contraste: extenso hematoma PT derecho de aprox 60 mL, con vaciamiento ventricular, sin hidrocefalia significativa

OBSERVACIONES:

- Vigil, orientada en espacio, parcialmente en tiempo, inatenta, sin alteración lenguaje, sin disartria leve-mod
- Pupilas isocoricas, RFM +/+, hemianopsia izquierda, OCM normal. Sensibilidad facial normal. PFC izquierda. Protruye lengua en linea media
- Hemiparesia izquierda BC M4 plantar extensor bilateral.
- Heminegligencia izquierda
- Coordinacion normal HC derecho
- Signos meningeos negativos.

Christian Alejandro Norambuena Aguayo
MEDICO TRATANTE
16447719-3

JEFE SERVICIO